

HACKATÓN

Transforma**gob**

2026

Desafío 14° - INEN

AtuncitoRevenge:

- Luiz Quineche
- César Cacho
- Kimberly Olivos

En colaboración con:



CLAD



BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA



Gobierno del Perú



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

#PorUnPerúDigital

Contenido:

1. desafío de innovación/alcance del propuesta
2. Propuesta de solución
3. prototipo
4. impacto esperado
5. viabilidad.

1. Desafío de innovación / alcance de la propuesta

¿Cómo podríamos ayudar a las mujeres de 30 a 65 años en situación de vulnerabilidad con sospecha de cáncer de mama y cervix atendidas en el INEN a superar las demoras y la fragmentación del proceso diagnóstico, para lograr diagnósticos más tempranos?

El problema, en cifras (INEN):

- **93.3%** de las primeras citas tardan más de 1 día (promedio: 3 días 14 h)
- **11.54 días** promedio de atención de referencias por REFCON (hasta 20 en marzo)
- **51.29%** de casos nuevos sin estadio clínico registrado
- **~30%** se diagnostican en estadios avanzados (III–IV).
- **70%** de pacientes se desplazaba repetidamente entre servicios sin orientación

Alcance de la propuesta (qué SÍ)

- Centraliza el estado del caso y los siguientes pasos.
- Recuerda y alerta citas, exámenes e hitos del proceso.
- Orienta de forma clara, inclusiva e intercultural (es/qu).
- No incluye diagnóstico por IA ni HC electrónica completa.
- Interoperabilidad progresiva sin afectar la operación clínica.

2. Propuesta de solución

OncoRuta Mujer Inteligente

Descripción:

- Sistema digital de navegación del paciente que acompaña a la mujer durante todo su proceso diagnóstico: traduce el flujo institucional (BPMN y 9 hitos) en una ruta clara de 7 etapas, mostrando en qué etapa está, qué sigue y qué necesita; con recordatorios, orientación intercultural y acompañamiento continuo.

Público objetivo:

- **Mujeres de 30–65 años en situación de vulnerabilidad** con sospecha de cáncer de mama o cuello uterino · INEN-Lima

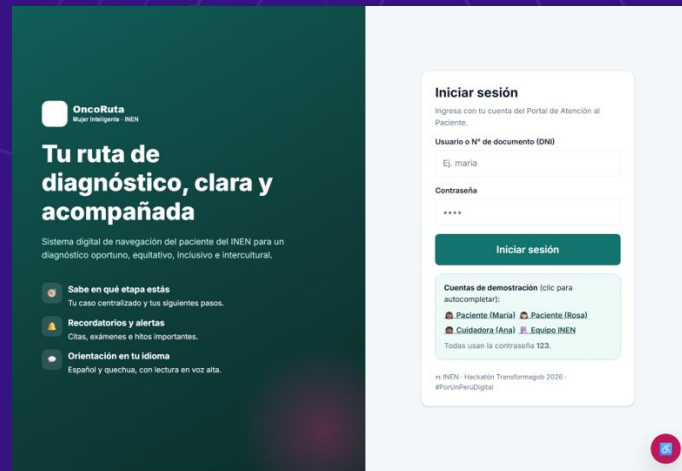
Beneficios y atributos:

- Reduce demoras, viajes y trámites innecesarios
- Disminuye la incertidumbre y la ansiedad
- Accesible: español/quechua, lectura en voz alta, texto grande
- Acceso para cuidadora/familiar autorizado
- Red de apoyo (Club de la Mama) integrada
- Panel institucional con priorización de casos vulnerables

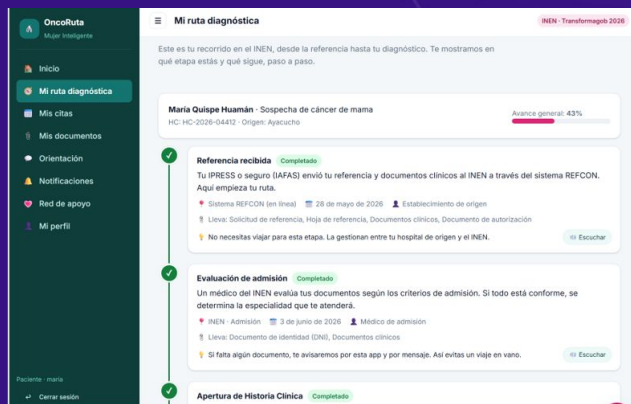
Actores involucrados en la solución

- **Paciente y cuidador/familiar** — usuarios principales
- **INEN – Oficina de Informática** — liderazgo y producto
- **Personal clínico y administrativo** — admisión, citas, exámenes
- **Club de la Mama** — validación y soporte de pares
- **IAFAS / IPRESS** — referencias (REFCON)
- **PCM / MINSA** — gobierno digital y normativa

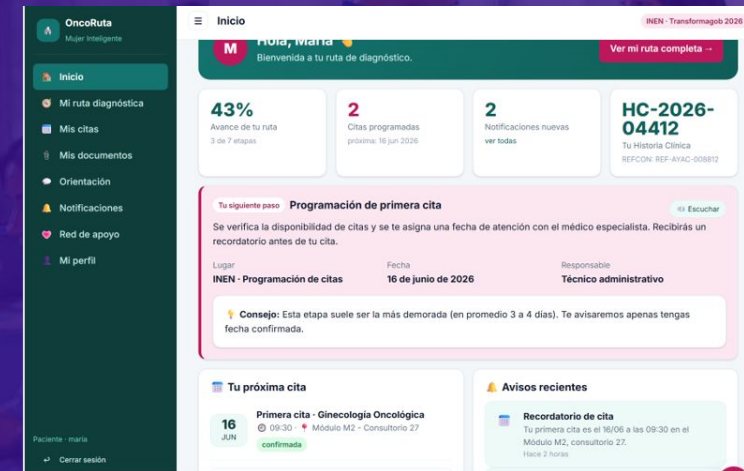
3. Prototipo



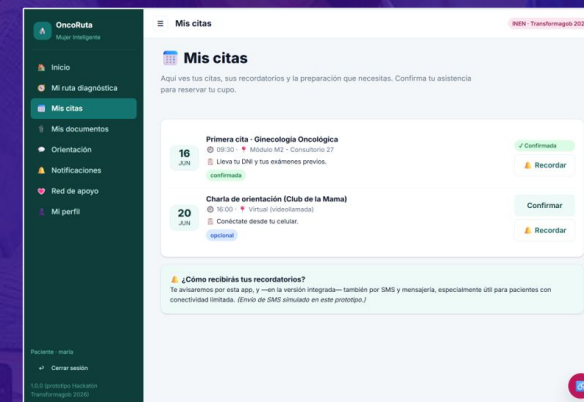
Inicio de sesión por rol (con cuentas demo)



Mi ruta diagnóstica (línea de tiempo de 7 etapas)



Inicio: estado del caso + 'tu siguiente paso'



Mis citas: recordatorios y confirmación

4. Impacto esperado

-40%

tiempo de programación
de 1.ª cita

≤60%

citas que tardan +1 día
(desde 93.3%)

+25pp

casos con estadio clínico
registrado a tiempo

-40%

viajes/desplazamientos
evitables

Impacto en las personas y en la institución:

- Diagnóstico más temprano → mejores probabilidades de tratamiento oportuno.
- Menos ansiedad e incertidumbre (insight central del trabajo de campo).
- Equidad para jefas de hogar, mujeres con discapacidad e interculturales.
- Ahorro familiar en transporte, alojamiento y días de trabajo.
- Continuidad asistencial y menor pérdida de seguimiento.
- Descongestión de ventanillas y trámites presenciales.
- Decisiones basadas en datos (panel institucional).
- Alineado a la Ley Nacional del Cáncer y la Política de Salud al 2030.

5. Viabilidad

Tecnológica

- Prototipo funcional ya construido (web sin dependencias)
- Arquitectura desacoplada: el backend real solo cambia 1 capa
- Interoperabilidad progresiva con SISINEN y REFCON
- Ligera y accesible (apta para conectividad limitada)

Logística / operativa

- Liderazgo de la Oficina de Informática del INEN
- Compromiso post-hackatón: incubación y pilotaje
- Validación con el Club de la Mama y mentores
- Se monta sobre el flujo actual sin interrumpirlo

Logística / operativa

- Cumple Ley 29733, Ley General de Salud y D. L. 1412
- Sin HC reales en la hackatón; consentimiento en piloto
- Bajo costo: sin licencias ni infraestructura de gran escala
- Sostenibilidad: presupuesto institucional + cooperación

Agradecimientos

Contacto



En colaboración con:



CLAD

CAF

FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

equipu

#PorUnPerúDigital